

NOTA TÉCNICA 02

Requisitos do documento fiscal e classificação do documento de reembolso

Esta Nota Técnica dá cumprimento aos arts. 73 e 74 do Regulamento Geral de Reembolso. Relaciona os campos obrigatórios do documento fiscal e estabelece a classificação prévia de que trata o art. 74. Ao fundamentar a decisão, cita-se NT-02, na forma do art. 6º, V, do Regulamento.

1. Alcance

1.1. Aplica-se a todo documento apresentado em pedido de reembolso por livre escolha, seja nota fiscal de serviço, recibo profissional ou documento equivalente, em qualquer formato — arquivo digital, imagem digitalizada ou fotografia.

1.2. A fotografia do documento é aceita desde que integralmente legível. Documento parcialmente ilegível recebe o mesmo tratamento do documento com campo ausente, na forma do art. 75 do Regulamento.

1.3. A ausência de campo obrigatório não implica indeferimento. Implica pendência documental, com indicação precisa do campo faltante, permanecendo o protocolo aberto na forma do art. 18 do Regulamento. Enquanto houver pendência, não se apura nem se informa valor de reembolso.

2. Campos obrigatórios do documento fiscal

Cam po	Denominação	Conteúdo exigido	Exigência	Observação
C1	Identificação do beneficiário	Nome completo do beneficiário atendido e o respectivo CPF.	Sim	Sem identificação não se confirma a titularidade do atendimento.
C2	Identificação do prestador	Nome completo ou razão social do profissional ou da clínica e o respectivo CPF ou CNPJ.	Sim	—
C3	Registro no conselho profissional	Número de inscrição do profissional executante no conselho competente (CRM, CRP, CREFITO, CRFa ou equivalente), com a sigla da unidade federativa.	Sim	Ausente ou inválido o registro, aplica-se o art. 68 do Regulamento.
C4	Data do atendimento	Data em que o atendimento foi efetivamente prestado, ainda que distinta da data de emissão do documento.	Sim	É a data que rege a carência (art. 21) e o prazo (art. 13).
C5	Descrição do procedimento	Descrição inequívoca do procedimento realizado e, quando disponível, o código TUSS correspondente.	Sim	Descrição genérica do tipo 'atendimento' ou 'serviços prestados' não satisfaz o campo.
C6	Valor	Valor total pago e, havendo mais de um procedimento ou mais de uma sessão, a discriminação individual dos valores.	Sim	Documento com valor global e múltiplos itens não discriminados enseja pendência.

Ca mpo	Denominação	Conteúdo exigido	Exigência	Observação
C7	Assinatura ou carimbo do prestador	Assinatura do profissional executante ou carimbo do estabelecimento emissor.	Sim	—
C8	Número da sessão no ano civil	Nas sessões de terapia, a indicação de qual sessão do ano civil o documento representa.	Somente terapias	Não constando, a operadora apura a sessão pelo histórico do beneficiário.
C9	Pedido médico	Nos exames de alta complexidade assinalados na Tabela URS, o pedido do profissional solicitante.	Somente alta complexidade	Art. 38 do Regulamento.
C10	Indicação clínica	Nos procedimentos do grupo 3 do Anexo IV, a indicação clínica expressa que afaste a finalidade estética.	Somente grupo 3 do Anexo IV	Arts. 55 e 60 do Regulamento.

2.1. Os campos C1 a C7 são exigidos em todo e qualquer documento fiscal, independentemente da categoria em que ele venha a ser classificado.

2.2. Os campos C8 a C10 são exigidos apenas nas hipóteses assinaladas na coluna de exigência. A ausência desses campos, fora dessas hipóteses, não gera pendência.

2.3. Havendo mais de um campo ausente, a pendência é registrada uma única vez, relacionando todos os campos faltantes, de modo a evitar sucessivas solicitações ao beneficiário.

3. Anexo A — Classificação do documento

3.1. Todo documento é previamente classificado em uma e apenas uma das sete categorias abaixo. A classificação determina as regras materiais aplicáveis e precede qualquer apuração de valor.

CONSULTA_MEDICA — Consulta médica. Atendimento em consultório ou pronto atendimento por médico de qualquer especialidade, inclusive psiquiatria. Regime: Teto do art. 35; carência do art. 22.

SESSAO_TERAPIA — Sessão de terapia. Sessão de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional ou fisioterapia, executada por profissional não médico inscrito no conselho respectivo. Regime: Arts. 40 a 42; carência do art. 24; relatório clínico na forma do art. 73, § 3º.

EXAME_DIAGNOSTICO — Exame diagnóstico. Exame laboratorial ou de imagem, com ou sem contraste. Regime: Tetos individuais da Tabela URS; carência do art. 23; art. 38 na alta complexidade.

RELATORIO_CLINICO — Relatório clínico. Relatório, laudo ou parecer emitido pelo profissional assistente, apresentado isoladamente ou em complementação a pedido anterior. Regime: Teto de TUSS-10104011; quando apresentado para sanar pendência do art. 73, § 3º, integra o protocolo original e não gera pedido autônomo.

MATERIAL_OPME — Material, órtese, prótese ou material especial. Aquisição ou fornecimento de prótese, órtese ou material especial, com ou sem procedimento associado. Regime: Encaminhamento obrigatório a analista humano, independentemente do valor — art. 78, § 1º.

DESPESA_NAO_COBERTA — Despesa não coberta. Documento fiscal legítimo e completo, mas relativo a procedimento ou despesa excluída pelo Anexo IV. Regime: Indeferimento de plano, sem apuração de valor e sem pendência — Anexo IV, item 7.4.

INVALIDO — Documento inválido. Documento que não é fiscal ou que não se refere a despesa assistencial: conta de consumo, comprovante bancário, cupom de estabelecimento comercial, imagem ilegível ou arquivo corrompido. Regime: Art. 76 do Regulamento; não gera pendência sanável nem apuração de valor.

4. Regras de classificação

4.1. A classificação segue a natureza do procedimento efetivamente prestado, e não a denominação atribuída pelo prestador no documento fiscal.

4.2. A consulta com médico psiquiatra é classificada como consulta médica, e não como sessão de terapia, ainda que integre acompanhamento psicoterápico em curso — parágrafo único do art. 35 do Regulamento.

4.3. A sessão conduzida por psicólogo é classificada como sessão de terapia, ainda que o documento fiscal a denomine consulta.

4.4. Documento que reúna procedimentos de categorias distintas é decomposto e cada item é classificado separadamente, desde que discriminados os valores. Não havendo discriminação, registra-se pendência do campo C6.

4.5. A classificação como documento inválido é reservada aos casos em que o arquivo não constitui documento fiscal de despesa assistencial. Não se classifica como inválido o documento fiscal legítimo ao qual falte campo obrigatório — este é caso de pendência — nem o documento fiscal relativo a despesa excluída — este é caso de despesa não coberta.

4.6. A classificação como material, órtese, prótese ou material especial impõe o encaminhamento a analista humano, independentemente do valor solicitado e ainda que toda a documentação esteja completa.

5. Anexo B — Códigos de pendência documental

5.1. Toda pendência registrada na forma do art. 18 do Regulamento recebe um código deste Anexo. O código identifica o campo faltante, a providência esperada do beneficiário e o campo da seção 2 a que a pendência se refere. Havendo mais de uma pendência no mesmo documento, todos os códigos são registrados de uma vez.

Código	Ocorrência	Campo	Providência
P01	Nome do beneficiário ausente	C1	Solicitar documento fiscal com o nome completo de quem foi atendido.
P02	CPF do beneficiário ausente ou ilegível	C1	Solicitar reemissão com o CPF do beneficiário atendido.
P03	Beneficiário do documento diverge da carteirinha	C1	Verificar titularidade; aplicando-se o art. 8º, orientar abertura de atendimento próprio.
P04	Identificação do prestador ausente	C2	Solicitar documento com nome ou razão social do prestador.
P05	CPF ou CNPJ do prestador ausente	C2	Solicitar reemissão com a inscrição fiscal do prestador.
P06	Registro no conselho profissional ausente	C3	Solicitar o número de inscrição no conselho competente.
P07	Registro no conselho ilegível	C3	Solicitar nova imagem legível do documento.
P08	Registro no conselho incompatível com o procedimento	C3	Conferir a habilitação; não sanada a divergência, aplica-se o art. 68.
P09	Data do atendimento ausente	C4	Solicitar documento com a data em que o atendimento foi prestado.
P10	Data do atendimento posterior à data de emissão	C4	Solicitar esclarecimento do prestador quanto à data correta.
P11	Data do atendimento ilegível	C4	Solicitar nova imagem legível.
P12	Descrição do procedimento genérica	C5	Solicitar descrição inequívoca ou o código TUSS do procedimento.
P13	Descrição do procedimento ausente	C5	Solicitar documento com a descrição do que foi realizado.
P14	Código TUSS inexistente na Tabela URS	C5	Reclassificar pela descrição na forma do art. 34; persistindo, solicitar correção.
P15	Valor total ausente	C6	Solicitar documento com o valor efetivamente pago.
P16	Valor global sem discriminação por item	C6	Solicitar discriminação individual dos procedimentos e das sessões.
P17	Divergência entre o valor por extenso e o numérico	C6	Solicitar reemissão do documento fiscal.
P18	Assinatura ou carimbo do prestador ausente	C7	Solicitar documento assinado ou carimbado.
P19	Número da sessão no ano civil ausente	C8	Apurar pelo histórico; não sendo possível, solicitar a informação ao prestador.
P20	Relatório clínico exigido pelo art. 41 ausente	C8	Solicitar relatório circunstanciado do profissional assistente.
P21	Relatório clínico sem indicação de manutenção do tratamento	C8	Solicitar complementação do relatório.
P22	Relatório clínico não assinado	C8	Solicitar relatório assinado pelo profissional assistente.
P23	Pedido médico ausente em exame de alta complexidade	C9	Solicitar o pedido do profissional solicitante.

Código	Ocorrência	Campo	Providência
P24	Pedido médico sem identificação do solicitante	C9	Solicitar pedido com nome e registro do solicitante.
P25	Indicação clínica ausente em procedimento do grupo 3 do Anexo IV	C10	Solicitar relatório com a condição tratada; ausente, aplica-se o art. 55.
P26	Indicação clínica genérica	C10	Solicitar identificação da condição tratada.
P27	Documento parcialmente ilegível	—	Solicitar nova digitalização ou fotografia integral do documento.
P28	Imagem cortada ou com bordas fora do enquadramento	—	Solicitar nova imagem com o documento inteiro.
P29	Arquivo corrompido ou em formato não suportado	—	Solicitar reenvio em formato de imagem ou PDF.
P30	Documento com rasura em campo obrigatório	—	Solicitar reemissão pelo prestador.
P31	Comprovante de pagamento ausente quando exigido	—	Solicitar comprovante correspondente ao documento fiscal.
P32	Documento em idioma estrangeiro sem tradução	—	Solicitar tradução simples dos campos obrigatórios; art. 69 quanto à conversão.
P33	Dados bancários do beneficiário ausentes	—	Solicitar conta para crédito do reembolso, na forma do art. 15.
P34	Divergência entre procedimento descrito e habilitação do executante	C3	Solicitar esclarecimento; persistindo, aplica-se o art. 68.
P35	Documento sem numeração fiscal quando exigível	—	Solicitar documento fiscal regular ou recibo com todos os campos da NT-02.

5.2. Os códigos P27 a P30 tratam de vícios de imagem e não de ausência de campo. Aplicam-se cumulativamente aos códigos de campo, quando for o caso.

5.3. Nenhum código deste Anexo autoriza indeferimento imediato. A pendência é sempre sanável e o protocolo permanece aberto pelo prazo do art. 19 do Regulamento. O indeferimento por documentação só ocorre depois de esgotado esse prazo sem manifestação do beneficiário.

5.4. Não se registra pendência para obter documento que a operadora já possui, nem para confirmar informação que o beneficiário já prestou no mesmo atendimento.

6. Ordem de verificação

6.1. Recomenda-se a seguinte ordem de verificação, por ser a que evita solicitações desnecessárias ao beneficiário: primeiro, se o arquivo é documento fiscal de despesa assistencial; segundo, a categoria do Anexo A; terceiro, se a despesa está excluída pelo Anexo IV; quarto, a alçada do art. 78; quinto, o vínculo, a carência e o prazo; sexto, os campos obrigatórios desta Nota Técnica; e por último, a apuração do valor.

6.2. Verificada exclusão do Anexo IV, não se prossegue à conferência de campos obrigatórios: a despesa não é coberta ainda que o documento esteja completo.

6.3. Verificada hipótese de encaminhamento a analista humano, não se apura nem se informa valor de reembolso ao beneficiário, ainda que o cálculo seja possível.

7. Anexo C — Casuística comentada

7.1. Os casos abaixo consolidam o entendimento da área de análise sobre situações recorrentes. Não criam regra nova: aplicam as já previstas no Regulamento, nesta Nota Técnica e no Anexo IV. Havendo conflito entre a solução aqui indicada e o texto normativo, prevalece o texto normativo.

Caso 01. Recibo de psicólogo intitulado 'consulta', sem menção a sessão. *Solução:* Classifica-se como sessão de terapia. A habilitação do executante prevalece sobre a denominação do documento.

Caso 02. Recibo de médico psiquiatra em acompanhamento psicoterápico continuado. *Solução:* Classifica-se como consulta médica, com o teto do art. 35, e não é computado no limite anual de sessões do art. 40.

Caso 03. Documento fiscal com valor global cobrindo dez sessões, sem detalhamento. *Solução:* Pendência do campo C6. Não se divide o valor global por estimativa.

Caso 04. Documento fiscal de dez sessões, com valores discriminados por data. *Solução:* Apura-se sessão a sessão, contando o prazo do art. 12 a partir da última data.

Caso 05. Beneficiário apresenta recibo de sessão realizada antes do cumprimento da carência. *Solução:* Indeferimento por carência, ainda que o documento esteja completo e o valor dentro do teto. Não é caso de pendência.

Caso 06. Sessão realizada após o cumprimento da carência, mas protocolada fora do prazo. *Solução:* Indeferimento por decadência, sem exame do mérito.

Caso 07. Sessão que ultrapassa o limite anual do art. 40. *Solução:* Indeferimento das sessões excedentes. A apresentação de relatório clínico não supre o limite anual.

Caso 08. Sessão que atinge o número a partir do qual se exige relatório, sem o relatório. *Solução:* Pendência documental, e não indeferimento. Não se apura nem se informa valor enquanto pendente.

Caso 09. Relatório clínico apresentado depois, dentro do prazo do art. 19. *Solução:* Retoma-se a análise do ponto em que foi interrompida, sem reinício de prazos.

Caso 10. Foto de conta de consumo enviada por engano. *Solução:* Documento inválido. Não gera pendência sanável; orienta-se o envio do documento correto e o protocolo permanece aberto.

Caso 11. Comprovante de transferência bancária ao prestador, sem recibo. *Solução:* Documento inválido para fins de classificação. O comprovante não substitui o documento fiscal, que deve ser solicitado.

Caso 12. Recibo legítimo de procedimento estético completo em todos os campos. *Solução:* Despesa não coberta. A exclusão do Anexo IV prevalece sobre teto e carência; não se registra pendência.

Caso 13. Drenagem linfática sem qualquer indicação clínica no documento. *Solução:* Presume-se estética, na forma do art. 55. Despesa não coberta.

Caso 14. Drenagem linfática com relatório indicando linfedema pós-operatório. *Solução:* Reembolsável como sessão de terapia, observados o teto da Tabela URS e a carência do art. 24.

Caso 15. Recibo com consulta e taxa de estacionamento discriminadas. *Solução:* Apura-se apenas a consulta. A taxa não integra a base de cálculo.

Caso 16. Recibo com consulta e taxa administrativa em valor único. *Solução:* Pendência do campo C6 antes de qualquer indeferimento.

Caso 17. Prótese de baixo valor, documentação completa. *Solução:* Encaminhamento a analista humano, independentemente do valor, na forma do art. 78, § 1º. Não se informa valor ao beneficiário.

Caso 18. Procedimento cujo valor solicitado excede o limite de alçada, mas cujo reembolso seria inferior a ele. *Solução:* Encaminhamento a analista. O limite é aferido sobre o valor solicitado, não sobre o apurado.

Caso 19. Beneficiário solicita reembolso de atendimento de seu cônjuge. *Solução:* Não se processa no atendimento em curso. Orienta-se a abertura de atendimento próprio, sem prestar qualquer informação sobre o terceiro.

Caso 20. Beneficiário titular solicita histórico de utilização de seu dependente. *Solução:* Mesma solução do caso anterior. A titularidade do contrato não afasta a vedação do art. 8º.

Caso 21. Documento fiscal emitido em nome de terceiro, com pagamento feito pelo beneficiário. *Solução:* Não reembolsável. O documento deve estar em nome de quem foi atendido.

Caso 22. Atendimento realizado por telessaúde. *Solução:* Equipara-se ao presencial para todos os efeitos, inclusive quanto a teto, carência e documentação.

Caso 23. Exame de alta complexidade sem o pedido médico. *Solução:* Pendência do campo C9. Não é hipótese de indeferimento imediato.

Caso 24. Exame de alta complexidade realizado em urgência, sem pedido médico. *Solução:* Dispensa-se o pedido, comprovada a urgência na forma do art. 26.

Caso 25. Atendimento realizado em dezembro e protocolado em janeiro do ano seguinte. *Solução:* Aplica-se a Tabela URS do exercício do atendimento, e não a do exercício do protocolo.

Caso 26. Despesa em moeda estrangeira. *Solução:* Converte-se pela taxa de câmbio de venda do dia do atendimento, aplicando-se os mesmos tetos.

Caso 27. Documento apresentado em duas imagens, faltando a segunda página. *Solução:* Pendência por documento incompleto. Solicita-se o envio de todas as páginas.

Caso 28. Mesmo recibo apresentado por dois canais diferentes. *Solução:* Duplicidade. Prevalece o primeiro protocolo; o segundo é encerrado com a devida explicação.

Caso 29. Beneficiário com contrato suspenso na data do atendimento, regularizado depois. *Solução:* Não faz jus ao reembolso daquele atendimento. A regularização produz

efeitos apenas para atendimentos futuros.

Caso 30. Beneficiário migrou de plano após o atendimento. *Solução:* Aplica-se o plano vigente na data do atendimento, inclusive quanto ao percentual de coparticipação.

Caso 31. Documento com data de emissão anterior à data do atendimento. *Solução:* Pendência para esclarecimento do prestador quanto à data correta.

Caso 32. Recibo de fisioterapia sem indicação clínica. *Solução:* Procedimento do grupo 3 do Anexo IV: pendência para apresentação da indicação; não apresentada, aplica-se a presunção do art. 55.

Caso 33. Consulta e sessão de terapia realizadas no mesmo dia, com profissionais distintos. *Solução:* Duas apurações independentes, cada uma com o seu teto e a sua categoria.

Caso 34. Duas consultas com o mesmo profissional em intervalo de dez dias. *Solução:* A segunda depende de justificativa clínica, na forma do art. 36.

Caso 35. Procedimento identificado apenas por nome comercial. *Solução:* Classifica-se pela natureza; não sendo possível, registra-se pendência do campo C5.

Caso 36. Relatório clínico apresentado isoladamente, sem pedido pendente. *Solução:* Classifica-se como relatório clínico e observa o teto próprio da Tabela URS, limitado a uma vez por ano civil.

7.2. Os casos deste Anexo são revistos semestralmente pela área normativa. A inclusão de um caso não afasta a análise das particularidades de cada pedido.

8. Anexo D — Conteúdo mínimo do relatório clínico

8.1. O relatório clínico exigido para as sessões de terapia, na forma do art. 73, § 3º, do Regulamento, deve conter: I — identificação do beneficiário; II — identificação e registro no conselho do profissional assistente; III — data de emissão; IV — período de acompanhamento a que se refere; V — número de sessões realizadas no ano civil; VI — indicação expressa quanto à manutenção do tratamento; VII — assinatura do profissional.

8.2. Não se exige do relatório a indicação de diagnóstico, código da Classificação Internacional de Doenças ou descrição de quadro clínico. Constando essas informações, elas não são reproduzidas em nenhuma comunicação ao beneficiário, na forma do art. 7º do Regulamento.

8.3. O relatório é válido para as sessões subsequentes do mesmo ano civil, salvo alteração do quadro que justifique novo relatório.

8.4. O relatório apresentado para sanar pendência integra o protocolo original e não constitui pedido autônomo de reembolso, ainda que o profissional cobre por sua emissão.

8.5. Relatório emitido por profissional diverso do que conduziu as sessões é aceito desde que ambos sejam habilitados e o documento identifique essa circunstância.

9. Anexo E — Conteúdo mínimo do pedido médico

9.1. O pedido médico exigido nos exames de alta complexidade deve conter: I — identificação do beneficiário; II — identificação e registro do profissional solicitante; III — descrição do exame solicitado; IV — data da solicitação.

9.2. O pedido é válido por 90 (noventa) dias contados de sua emissão, salvo prazo diverso nele consignado.

9.3. Um único pedido pode amparar mais de um exame, desde que todos estejam nele descritos.

9.4. O pedido é dispensado quando o exame houver sido realizado em caráter de urgência ou emergência, comprovada na forma do art. 26 do Regulamento.

Nota Técnica 02, publicada em 22 de dezembro de 2025. Substitui a Nota Técnica 01, de 2023. Não foi alterada por circular normativa posterior.